



3

56. ÅRGANG | 03 • 2019

ARTIKEL

Tema

Når krisen rammer
– pædagogiske og psykologiske
perspektiver på krisehåndtering

PPT nr. 3-2019

**Selv mord, selvmordsforsøg og
selvskade blandt de 13-19 årige**

Af Lillian Zöllner

PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK TIDSSKRIFT
FORLAGET SKOLEPSYKOLOGI • PÆDAGOGISKE PSYKOLOGERS FORENING

Selv mord, selvmordsforsøg og selvskade blandt de 13-19 årige



En del unge i vort velfærdssamfund ønsker ikke at leve. De forsøger at begå selvmord eller begår selvmord. Det er et paradoks, at vi lever i et land, hvor alle voksne vil børn og unge det bedste. De får tøj på kroppen, de har et sted at bo, de får mad hver dag, og uddannelse er gratis. Hovedparten af de unge over 13 år har en mobiltelefon, de har en iPad eller en computer, og de er på de sociale medier. Men i alle sociale lag er der børn og unge, som ikke vil leve. Og vi har vidst det i mange år.

Af Lillian Zöllner, centerleder Center for Selvmordsforskning, ph.d.

Indledning

Hvis vi forsøger at se på undersøgelser og registreringer fra andre lande, er der grund til at være forsigtig. WHO (2014) peger i deres rapport på, at registrering af selvmord og selvmordsforsøg er kompliceret, og data fra forskellige lande kan være behæftede med fejl grundet forskellige registreringssystemer, mangel på data og andre forhold. I Sverige er der peget på forvirring om definition og klassifikation (SBU, 2015).

Også i Danmark anvendes forskellige definitioner af begreberne (Zöllner 2002a, 2006; Möhl, 2005, Strøbæk et. al., 2015). Derfor er det ikke muligt at sammenligne resultaterne i de forskellige lande eller i de forskellige undersøgelser.

I denne artikel vil hver enkelt begreb først blive defineret, hvorefter talene præsenteres.

Selv mord

WHO anvender en definition af begrebet selvmord, som i sig ikke rummer en etisk stillingtagen til, om handlingen er rigtig eller forkert, god eller ond. Der er snarere tale om en værdi-neutral forklaring på, hvori handlingen består, hvilken effekt handlingen har samt formålet med handlingen. Selvmord er ifølge WHO's definition følgende:

En handling med dødelig udgang, som afdøde, med viden eller forventning om et dødeligt udfald, havde foranstaltet og gennemført med det formål at fremkalde de af den døde ønskede forandringer.

(Sundhedsstyrelsen, 1998).

Sundhedsstyrelsens definition forudsætter ikke, at afdøde forud for sin handling havde et ønske om at dø, men kun at den afdøde skal have ønsket forandringer. Begrundelsen herfor er, at det kan være meget vanskeligt at

fastslå, hvad den afdøde klart havde forestillet sig, resultatet af handlingen ville være. Derfor anvendes både begreberne viden og forventning.

WHO's definition og den danske definition er rensat for ethvert værdiladet udtryk, som kunne danne grundlag for etisk eller moralsk stillingtagen. Selvmord er ikke værdineutralt set i et samfundsperspektiv, men er tværtimod omgærdet af en lang række etiske overvejelser og moralske vurderinger. Dette bliver tydeligt, hvis man anvender andre begreber for menneskets ønske om at ville dø samt dets handlinger i forbindelse hermed.

Gennem mange år har det forholdt sig sådan, at selvmord i større udstrækning begås af unge mænd og i mindre udstrækning af unge kvinder. Dette gælder ikke blot for Danmark,

men er tilfældet i de fleste europæiske lande (WHO, 2014).

Center for Selvmordsforskning fører Register for Selvmord. Som det fremgår af fig. 1 har selvmordsraten blandt unge mænd i alderen 15-19 år været højere i årene 2006 – 2014 i forhold til selvmordsraten blandt unge kvinder i samme alder. I 2015 skete der et skift, idet raten for unge kvinder var højere end raten for unge mænd. Det er dog usikkert, om der er tale om en varig ændring.

Både de unge mænd og de unge kvinder anvender primært en determinel metode ved selvmord som f.eks. hængning.

Selvmodsforsøg

Intentional Self-harm er en betegnelse, som anvendes i det internationale klas-

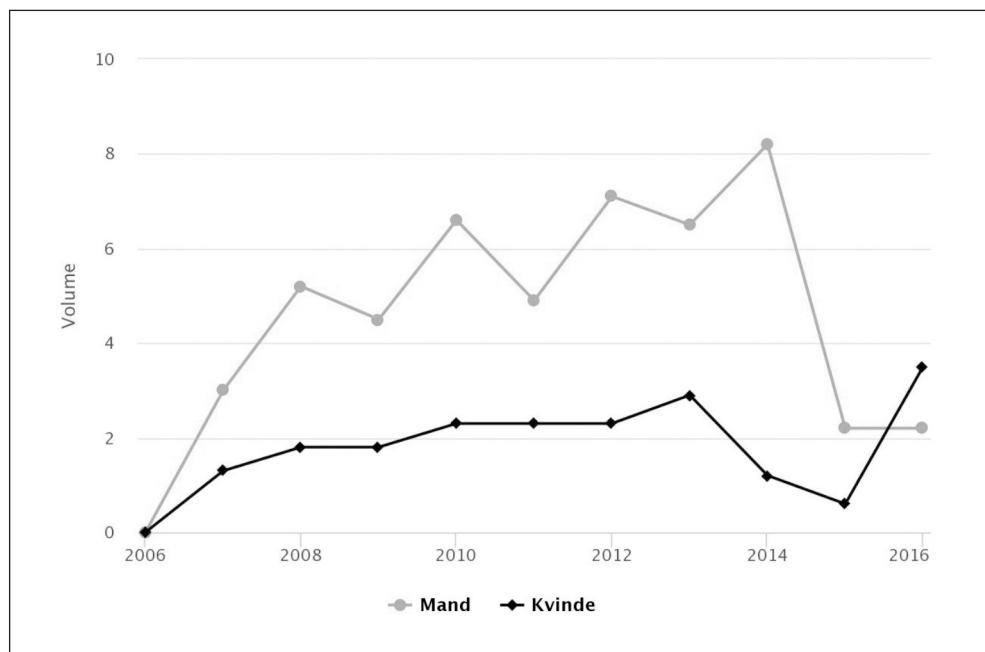


Fig. 1: Selvmordsrate blandt de 15-19 årige

sifikationssystem (ICD 10 Classification of Mental and Behavioural Disorders). Selvskade registreres under punkterne fra X60 til X84. I Danmark anvendes dette internationale klassifikationssystem om de personer, som indbringes til sygehus efter en selvskade.

Hvorvidt der *er* tale om et selvmordsforsøg beror på en validering af hver enkelt registrering. Det har vist sig, at der er registreret et større antal selvmordsforsøg, som ikke opfylder WHO's definition, som i dansk oversættelse har følgende ordlyd:

“En handling uden dødelig udgang, hvor en person med vilje indtager en overdosis medicin eller lignende eller udviser anden ikkevanemæssig adfærd, der vil være skadevoldende, hvis ikke andre griber ind, og hvor hensigten har været at fremme vedkommendes ønskede forandringer via handlingens forventede konsekvenser (Sundhedsstyrelsen, 1998).

WHO's definition er tilstræbt værdi-neutral, således at den kan accepteres på tværs af kulturer, religioner og ideologier. Den tager udgangspunkt i selve handlingen, idet begrebet “skadevoldende” anvendes, hvorimod intentionen om “at dø” ikke nævnes. Imidlertid har WHO's definition givet anledning til overvejelser, idet *attempted suicide* dækker over en lang række handlinger, hvor selve handlingernes hensigter og metoder er vidt forskellige (Kerkhof, 2000). Definitionen rummer endvidere et krav om, at adfærden ikke er vanemæssig, dvs. at personen ikke jævnligt, hyppigt eller tilbagevendende skader sig selv (f.eks. cutting). I definitionen er der yderligere et krav om, at adfærden skal volde skade, hvis andre

ikke griber ind. Som eksempel kan nævnes indgriben ved forsøg på at drukne sig selv eller indgriben efter en overdosis medicin, hvor personen er bevidstløs. Et tredje eksempel er indgriben ved forsøg på selvmord ved togpåkørsel.

I definitionen anvendes udtrykket “hvor hensigten har været at fremme vedkommendes ønskede forandringer via handlingens forventede konsekvenser”. De ønskede forandringer kan f.eks. være, at kæresten kommer tilbage, eller at livet ikke er så hårdt. Men de ønskede forandringer kan være vidt forskellige afhængige af den unges livssituation og livshistorie.

Nogle unge har gennemført adskillige selvmordsforsøg, hvor metoderne bliver mere og mere alvorlige (f.eks. forsøg på at hænge sig eller skyde sig selv), hvorimod andre unge kun forsøger én enkelt gang. De anvender en metode og et tidspunkt, som minimerer risikoen for at dø, idet hensigten er en ganske anden nemlig et forsøg på at kommunikere behov for hjælp, opmærksomhed, pleje, omsorg eller placering af skyld. De kan føle sig fanget i en fælde, som de ikke ved, hvordan de skal komme ud af.

I internationale sammenhænge har forskere og behandlere forsøgt at fremkomme med definitioner, hvor intentionen indgår. Samtlige definitioner lider imidlertid under det faktum ikke at være helt dækkende for de mange forskellige slags intentioner og handlinger, som ligger til grund for et selvmordsforsøg.

For at få en mere nøjagtig viden om problemet på landsplan indsamler Center for Selvmordsforskning data på

Tabel 1: Selvmordsforsøg i alderen 15-19 år 2012-2016

År	Region Nordjylland				Region Sjælland			
	Antal Mænd	Antal Kvinder	Antal I alt	Rate pr. 100.000	Antal Mænd	Antal Kvinder	Antal I alt	Rate pr. 100.000
2012	6	21	27	69,6	5	51	56	101,4
2013	5	20	25	65,4	6	42	48	87,5
2014	9	77	86	228,8	5	40	45	82,8
2015	11	56	67	181,5	5	24	29	53,9
2016	8	89	97	267,9	9	34	43	80,6

sygehuse/skadestuer i regionerne. Ved indhentning af data foretages samtidig validering af disse, således at de data, der indgår i Register for Selvmordsforsøg er i overensstemmelse med WHO's definition på selvmordsforsøg.

Som det fremgår af tabel 1 kan der være store forskelle i raterne for selvmordsforsøg blandt unge i Region Nordjylland og i Region Sjælland (Larsen & Mikkelsen, 2017). Raten i 2012 og i 2013 er betydelig højere i Region Sjælland end i Region Nordjylland. En lang række vidt forskellige faktorer kan være medvirkende til, at det forholder sig sådan.

Ud over selvmordsforsøg blandt de 15-19-årige ses selvmordsforsøg i alderen 6-14 år. I begge regioner er der en overvægt af unge pigers/kvinders selvmordsforsøg i forhold til de unge drenge/mænds selvmordsforsøg. Den hyppigst anvendte metode blandt de unge er forgiftning efterfulgt af skær eller stik (ibid.). Fra journalerne er der indhentet oplysninger om, hvilke bagvedliggende (distale) årsager, de unge angiver som værende begrundelse for selvmordsforsøget. Desuden er der indhentet oplysninger om de udløsende (proximale) faktorer.

Blandt de 6-14-årige piger og de 15-19-årige piger er den hyppigst registrerede distale årsag psykisk sygdom. For de 6-14-årige samt de 15-19-årige drenge vedkommende er den hyppigst registrerede distale årsag ligeledes psykisk sygdom.

De registrerede proximale faktorer er for de 6-14-årige piger skænderi, uoverensstemmelse, konflikt med nær person, mens det for de 15-19 årige er psykisk sygdom efterfulgt af skænderi, uoverensstemmelse, konflikt med en nær person (ibid.).

Det forholder sig omvendt for drengene i samme aldersgrupper. Hvor de hyppigste proximale faktorer for de 6-14-årige er psykisk sygdom, er det for de 15-19 årige drenge skænderi/uoverensstemmelse/konflikt. Om de unge har haft alvorlige selvmordstanke uger eller måneder før selvmordsforsøget er usikkert.

Selvskade

Der er ikke enighed om definitionen af selvskade, og der er grund til at udvise stor forsigtighed med at sammenligne forskningsresultater eller resultater af andre undersøgelser. Især to begreber dominerer inden for forskning om selv-

skade: Non-Suicidal Self-Injury (NSSI), der ofte anvendes i USA og Canada og Deliberate Self-Harm (DSH), som ofte anvendes i europæisk og australsk forskning (SBU, 2015). Nogle undersøgelser omfatter både selvskade ud fra NSSI-definitionen og ud fra DSH-definitionen, hvilket yderligere understreger muligheden for fejltolkninger ved at sammenligne resultater inden for landets grænser og på tværs af landegrænser.

Siden 2000 har Center for Selvmordsforskning anvendt følgende definition for selvskade (Zöllner, 2002b):

En handling uden dødelig udgang, hvor en person med vilje foretog sig en eller flere af følgende ting:

- tog initiativ til handling (fx snitte sig selv, springe fra højde) med den hensigt at skade sig selv
- indtog et stof udover den foreskrevne eller generelt anbefalede terapeutiske dosis
- indtog et afslappende (recreational) eller ulovligt stof (drug) som en handling, som personen anså for at ville være selvskadende
- indtog et ikke-indtageligt objekt eller et stof

Selvskade ses i denne sammenhæng som et mere omfattende begreb end begrebet selvmordsforsøg. Definitionen er primært rettet mod det bevidste adfærdsmæssige (med vilje), uden at handlingen behøver at være gennemført (tog initiativ til handling). Endvidere skal hensigten med handlingen være at skade sig selv. I modsætning til definitionen af selvmordsforsøg behøver andre ikke at have grebet ind, og

i definitionen af selvskade indgår ikke, at der skal være tale om ønskede forandringer som konsekvens af handlingen. Som eksempel på selvskade kan nævnes indtagelse af en overdosis piller (f.eks. 30 Panodil) med den hensigt at skade sig selv. Den unge kaster efterfølgende pillerne op.

Center for Selvmordsforskning har siden 2001 årligt indsamlet data om unges selvskade gennem spørgeskemaundersøgelser. Oprindeligt blev forskningsprojektet igangsat som et europæisk samarbejde for en toårig periode (Zöllner 2002b), men Center for Selvmordsforskning har kontinuerligt fortsat dataindsamlingen med henblik på at undersøge udviklingen over tid set i lyset af de forandringer, samfundsudviklingen byder på. Dataindsamlingen fra 2001-2017 omfatter besvarelser om sårbarhed, alvorlige tanker om selvskade og selvskade fra mere end 39.500 unge i alderen 13-19 år.

Fra 2001 til 2011 har andelen af unge sårbare varieret, men mere end 10 % af de 13-19-årige føler, de har problemer, som kræver professionel hjælp (Zöllner, 2014). Som det fremgår af Tabel 2 er andelen af sårbare svagt stigende fra 2012 til 2017. Der er stadig flere unge kvinder, der er sårbare i forhold til de unge mænd.

Desværre viser tallene, at der er mere end en fjerdedel af de unge, som har alvorlige tanker om at skade sig selv (Tabel 2). Endvidere fremgår det, at det i større udstrækning er de unge kvinder i forhold til de unge mænd, som alvorligt har tænkt på at skade sig selv. Fra 2001 til 2011 har udviklingen stort set været den samme (ibid.).

Tabel 2: Sårbarhed, alvorlige tanker om selvskade og selvskade. Alder 13-19 år

Procent

Årstal	Sårbar			Alvorlige tanker			Selvskade		
	Total	Kvinder	Mænd	Total	Kvinder	Mænd	Total	Kvinder	Mænd
2012	11,1	16,2	5,4	26,3	37,2	14,5	14,8	22,6	6,3
2014	11,2	16,6	5,9	26,7	36,9	16,4	17,3	25,7	8,9
2015	12,7	19,2	6,2	28,6	39,5	17,8	17,4	26,3	8,4
2016	13,7	20,5	6,8	27,4	37,0	17,8	15,8	23,8	7,6
2017	13,8	20,4	7,1	27,0	37,3	16,5	17,2	25,9	8,5

I perioden fra 2001 til 2011 har der været en nogenlunde konstant stigning i andelen af unge, som skader sig selv. Disse unge kommer ikke i forbindelse med hospital eller praktiserende læge som følge af deres selvskade. Gennem årene har det primært været de unge kvinder, som har skadet sig selv flere gange i forhold til de unge mænd. I 2011 var der næsten 4 gange så mange unge kvinder end unge mænd, som havde skadet sig selv én eller flere gange (ibid.). Som det fremgår af Tabel 2, viser tallene fra 2012 til 2017, at andelen af selvskadende unge stort set er den samme. De seneste tal fra 2017 viser, at 26 % af de unge kvinder har skadet sig selv én eller flere gange. 17 % af de unge i alderen 13-19 år på uddannelsesinstitutionerne i Danmark har i 2017 én eller flere gange skadet sig selv.

I 2015 undersøgte Center for Selvmordsforskning omfanget af selvskade blandt herboende unge fra vestlige lande og fra ikke-vestlige lande¹. Resulta-

terne viser, at selvskade findes blandt såvel unge fra vestlige lande som fra ikke vestlige lande (Zöllner, 2015).

Belastende og beskyttende faktorer

Forskningen har de seneste tyve år primært koncentreret sig om risikofaktorerne for at unge begår selvmord eller forsøger at begå selvmord (Agerbo et al, 2002, Christiansen, E. (2015). Tiden er inde til at undersøge, hvad der beskytter unge mod alvorlige tanker om, at livet ikke er værd at leve.

En undersøgelse (Jensen og Zöllner, 2016) viser, at bedsteforældre er en beskyttende faktor for unges selvskadende adfærd. Langt de fleste unge (93 %) har eller har haft et godt forhold til mindst én af bedsteforældrene. De unge lægger bl.a. vægt på omsorg, kærlighed og det at lave noget sammen,

Canada, USA, Australien og New Zealand. Ikke-vestlige lande er alle øvrige lande. En ung med en vestlig baggrund betyder at personen er født og har statsborgerskab i et vestligt land samt at mindst én af forældrene er født og har statsborgerskab i et vestligt land.

1 Vestlige lande er alle EU-lande plus Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten,

når de beskriver, hvad der betyder noget i deres forhold til bedsteforældrene.

Viden om beskyttende faktorer kan bringe os i en position, hvor vi forebygger i stedet for at helbrede.

Muligheder for forebyggelse

Uddannelsesinstitutionerne er det sted, hvor der findes en struktur, som gør det muligt at gennemføre en forebyggende indsats, både når det drejer sig om selvskade, selvmordsforsøg og selvmord. WHO pegede i 2014 på dette. Desuden er der mange muligheder for, at de unge kan få rådgivning gennem telefonen eller via nettet: Livslinien, Børnetelefonen, Danner, Børn, Unge & Sorg, Ventilen, Psykiatrifonden og Regionale Centre for Selvmordsforebyggelse. Desuden kan de unge få hjælp ved at henvende sig til praktiserende læger samt til præster. Førstnævnte gruppe kan samtale, behandle og henvise til psykiatrien. Sidstnævnte faggruppe har flere steder i landet oprettet lokale støttemuligheder, og præsterne er tilgængelige 24 timer i døgnet og er underlagt tavshedspligt. En del unge går til konfirmationsforberedelse, men uanset om det er i forbindelse med konfirmationsforberedelse eller ej, har præster en mulighed for at være en samtalepartner.

De unge kan henvises til psykologer eller til psykiatere, eller de kan henvende sig til studievejledere, socialrådgivere og sundhedsplejersker. Forskellige steder i landet er der flere lokale/kommunale hjælpemuligheder til de unge.

De elektroniske midler er lettilgængelige, og de unge er vant til at bruge dem. Men det er ikke den form for

hjælp, de unge vil have (Zøllner, 2015). De kan ikke ud af en telefonsamtale tolke personens nærvær og tilstedeværelse. Deres erfaringer med de elektroniske medier kan måske netop være årsagen til, at telefon og net vælges fra. Det er anonymt og giver ikke nødvendigvis følelsen af nærvær.

Tillid er afgørende. Det kan være meget, meget vanskeligt at fortælle om flere tabubelagte forhold (selvskadende adfærd, selvmordsforsøg) til en person, hvis den person, der skal hjælpe, ikke er bevidst om, at den unge vover sig frem for at blive imødekommet. En tidligere undersøgelse (Zøllner, 2002b) viser, at lærere, forældre og elever har forskellige holdninger til selvskade. Tilsyneladende tror de voksne, at de unge skader sig selv for at få opmærksomhed. Denne holdning deles ikke af de unge.

Ikke alle forældre kan magte at høre, at deres barn ikke har lyst til at leve, og ikke alle forældre reagerer ved at opfordre den unge til at fortælle mere om deres tanker og adfærd. Nogle forældre kan blive så forfærdede, at de siger, at de ikke kan holde ud at høre på det. Forældrenes afmagt i disse situationer hjælper ikke den unge.

Måske er det tid til at overveje, hvordan vi *alle* kan bidrage til forebyggelsen af unges sårbarhed, selvskade og selvmordsadfærd? Børns og unges livshåb, livsmod og livsuelighed erhverves og trænes ikke nødvendigvis ved diagnose, medicinering, psykologbi-stand eller psykiatrisk bistand. Børns og unges livsmod bibringes heller ikke nødvendigvis gennem forældres timer hos psykolog eller parterapeut. Det er også usikkert, om livshåbet og livsmod

det næres ved gentagne skoletest, måling og individualisering. De mange muligheder for at være synlig på de sociale medier giver tilsyneladende heller ikke børn og unge følelsen af nærvær og tryghed, når livet forekommer dem uudholdeligt.

Børn fødes ikke med en lyst til at begå selvmord i det velfærdssamfund, de vokser op i. Tankerne, om at livet ikke er værd at leve, kan komme, men de kan også forsvinde for aldrig nogen sinde at dukke op igen. De unge, som har alvorlige selvmordstanker, har brug for at erfare, at der er et mindst ét menneske, som gør en forskel. Et menneske, som ser det som sin etiske forpligtelse at tage hånd om barnet eller den unge.

I utallige sammenhænge har det vist sig, at den store ændring i et ungt menneskes liv er indledt, fordi et enkelt menneske gjorde en forskel. Ikke nødvendigvis en psykiater, en læge, en psykolog, en socialrådgiver, en lærer eller en forælder. Men et menneske i den unges liv, som har været der for den for den unge. Et menneske, som ikke har bagatelliseret den unges betroelser.

Afslutning

Det er os voksne, der skal tolke den unges betroelser og adfærd. Det betyder ikke, at vi voksne skal efterkomme den unges ønsker og forventninger eller være eftergivende. Det betyder heller ikke, at vi skal foregøgle den unge, at livet er retfærdigt, eller at livet bliver retfærdigt.

Det betyder, at vi skal være i stand til at tolke, hvordan vi mener, den enkelte sårbare unge med alvorlige selv-

mordstanker bedst kan hjælpes, så livshåbet og livsmodet vender tilbage. At være i stand til at tolke den unges tale og adfærd kræver, at vi i mødet med den unge er nærværende og til stede. Vi voksne er ikke nærværende, lyttende og til stede samtidig med, at vi har et blik på mobiltelefonen og besvarer sms'er, læser eller skriver på de sociale medier. Det er beskæmmende, at vi voksne ikke har modet til at tage et ansvar for, at den gode samtale skal blive en realitet. Vi kan ikke forlange eller bestille tid til en god samtale. Den unikke samtale kan opstå, når vi mindst venter det.

Referencer

- Agerbo, E., Nordentoft, M., & Mortensen, P.B. (2002). Familiar psychiatric and socioeconomic risk factors for suicide in young people: Nested case-control study. *British Medical Journal*, 325, 74.
- Christiansen, E. (2015). *Risk factors and consequences of child and youth suicide attempts – a Danish register-based study*. University of Southern Denmark.
- Jensen, S.G. (2015). *Bedsteforældre – en beskyttende faktor*. Nyt fra Center for Selvmordsforskning, Årg. 12, nr. 3
- Jensen, S.G., Zöllner, L. (2016). *Beskyttende faktorer for unge med selvskadende adfærd*. Center for Selvmordsforskning.
- Kerkhof, J.F.M (2000). *Attempted Suicide: Patterns and Trends*: I: Hawton, Keith and van Heeringen, Kees (Eds). *The International Handbook of Suicide and Attempted Suicide*. Chichester, UK, 49-64.
- Larsen, C.P. & Mikkelsen, A.K.T. (2017). *Register for selvmordsforsøg 2012-2016. Udvildelse af Register for Selvmordsforsøg fra et regionalt til et nationalt register*. Center for Selvmordsforskning.
- Møhl, B. (2005). At skære smerten bort – om cutting som drug. I: *Psyke & Logos*, 26, 98-117.
- SBU. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2015). *Skolebaserade program för att förebygga självska-*

- tende inklusive suicidförsøg. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm.
- Strøbæk, L., Flachs E.M., Ryd J.T., Davidsen, M., Eriksen, L., Jensen H.A.R., White E.D., Juel K. (2015). *Sygdomsbyrden i Danmark – ulykker, selvskaade og selvmord*. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet for Sundhedsstyrelsen.
- Sundhedsstyrelsen (1998). *Forslag til handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark*. Udvalget til udarbejdelse af forslag til handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg i Danmark.
- Sundhedsstyrelsen (1998). *Bilagsdel til forslag til handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark*. Udvalget til udarbejdelse af forslag til handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg i Danmark.
- WHO World Health Organization (2014). *Preventing suicide: A global imperative*. Geneva.
- Zöllner, L. (2002a). *Definitioner på selvmordsadfærd og selvskaade*. Center for Selvmordsforskning. Faktaserien nr. 1.
- Zöllner, L. (2002b). *Unge (Mis)trivsel*. Center for Selvmordsforskning.
- Zöllner, L. (2002c). Udsatte og sårbare unges signaler- set i et selvmordsforebyggelsesperspektiv. *Nordisk Psykologi*, 54 (4), 287-300
- Zöllner, L. (2006). *Centrale begreber inden for selvskaadende adfærd*. Center for Selvmordsforskning. Faktaserien nr. 21
- Zöllner, L. & Jensen, B. (2010): *Selvskaadende adfærd blandt unge*. Center for Selvmordsforskning.
- Zöllner, L. (2014). *Unge selvskaadende adfærd 2001-2011*. Center for Selvmordsforskning.
- Zöllner, L. (2015) *Kærestevold og dets følger*. Center for Selvmordsforskning.